

AKUT DIVERTIKULIT

Diagnostik • Klassifikation • Uppföljning

01 DIAGNOSTIK

DT buk med kontrast är förstahandsval.
Utan kontrast kan okomplicerad divertikulit ses, men komplikationer behöver ofta kontrast för säker bedömning.

02 KLASSIFICERA FYNDEN

● OKOMPLICERAD

Hinchey 0–Ia

Lokal inflammation utan abscess, gas eller fistel.

● KOMPLICERAD

Hinchey Ib–IV

Abscess, perforation, fri gas, fistel eller obstruktion.

03 PLANERA KOLONUTREDNING

INGEN RUTINMÄSSIG UTREDNING

Alla tre villkor uppfyllda och ingen indikation i rutan till höger:

- Okomplicerad divertikulit
- Bekräftad med DT med intravenös kontrast.
- Återställd efter 6 veckor

UTRED EFTER 6–8 VECKOR

Kolonutredning är motiverad vid:

- Klinisk diagnos utan DT + tidigare kolonutredning saknas eller är >3 år gammal.
- Komplicerad divertikulit + tidigare kolonutredning saknas eller är >3 år gammal.
- Oklara radiologiska fynd där malignitet inte kan uteslutas.
- Recidiv av okomplicerad divertikulit hos patient som inte tidigare utretts.

METOD

Koloskopi eller DT-kolon (>75 år).

● PATIENTRÅD

Patienten ska kontakta vården om förbättring uteblir.

OM SAMMANFATTNINGEN

Detta är en sammanfattning av det angivna källdokumentet, genererad av Kjell Stefansson, ST-läkare i akutsjukvård, med hjälp av AI. Sammanfattningen ersätter inte originaldokumentet. Kontrollera aktuell version och lokal tillämplighet.